

CAPÍTULO 1.10

Fibrilación Auricular de Reciente Comienzo

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La **fibrilación auricular (FA)** de reciente comienzo requiere un manejo específico que difiere ligeramente del manejo crónico, especialmente en la fase aguda. La prioridad es estabilizar al paciente y prevenir complicaciones.

Manejo Inicial de la Fibrilación Auricular de Reciente Comienzo

El primer paso en el manejo de la FA de reciente comienzo depende de la estabilidad hemodinámica del paciente.

Fibrilación Auricular con Inestabilidad Hemodinámica

- Si el paciente presenta **inestabilidad hemodinámica** (ej. hipotensión, shock, signos de isquemia miocárdica, edema pulmonar agudo, alteración del nivel de conciencia), la medida más urgente es la **cardioversión eléctrica inmediata**.

Fibrilación Auricular con Estabilidad Hemodinámica

- Si el paciente está **hemodinámicamente estable**, el manejo inicial se centra en el control farmacológico.

Control de la Frecuencia Cardíaca

El control de la frecuencia cardíaca es la primera medida en pacientes estables.

- Primera línea:**
 - **Propranolol endovenoso**.
 - **Verapamilo endovenoso** o **Diltiazem endovenoso** (calcioantagonistas no dihidropiridínicos).
- Segunda línea (si los anteriores están contraindicados o no funcionan):**
 - **Digoxina**.
- Última línea (para control de frecuencia, con precaución):**
 - **Amiodarona**. Si bien la amiodarona es un antiarrítmico que se usa principalmente para el control del ritmo, puede emplearse para el control de la frecuencia cuando otras opciones han fallado. Sin embargo, existe el riesgo de cardiovertir y/o bradicardizar excesivamente al paciente.

Anticoagulación en FA de Reciente Comienzo

La anticoagulación es una medida crucial para prevenir eventos tromboembólicos.

EUNACOM CRITERIOS

En la **FA de reciente comienzo o reciente diagnóstico**, se debe anticoagular a **todas o casi todas** las pacientes en la fase aguda.

- Excepciones a la anticoagulación:**
 - **Contraindicación absoluta:** Si existe una contraindicación clara para la anticoagulación (ej. hemorragia digestiva alta activa, **accidente cerebrovascular hemorrágico**, politraumatismo grave).
 - **FA autolimitada:** Una FA que duró menos de 24 horas, cardiovertió espontáneamente y el paciente tiene un score de **CHA2DS2-VASc de 0 puntos**. En este caso, se podría considerar no anticoagular, pero es una excepción rara.
- Anticoagulación a largo plazo:**
 - La decisión de mantener la anticoagulación de forma permanente (al alta) se basa en el score **CHA2DS2-VASc**, de la misma manera que en la **Fibrilación auricular crónica**.

Cardioversión Farmacológica

La cardioversión busca restaurar el ritmo sinusal. El principal riesgo de la cardioversión es la **embolia**, ya que un trombo formado en la aurícula fibrilando puede desprenderse al restaurarse la contracción auricular.

¿Cuándo cardiovertir?

Existen dos estrategias principales:

- Anticoagulación diferida:** Anticoagular al paciente durante **3 a 4 semanas** antes de intentar la cardioversión. Esto permite que cualquier trombo preexistente se lise o se adhiera firmemente a la pared auricular, reduciendo el riesgo de embolia. No se ha demostrado beneficio adicional por cardiovertir de inmediato en pacientes estables.
- Eco transesofágico (ETE):** Realizar un **Ecocardiografía transesofágica** para descartar la presencia de trombos intraauriculares. Si el ETE es normal, se puede proceder a la cardioversión de inmediato.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La decisión de cardiovertir en pacientes con FA de menos de 48 horas de duración sin ETE disponible es **controvertida**. Aunque el riesgo de trombo es bajo, no es nulo. La decisión debe individualizarse considerando los factores de riesgo del paciente y la disponibilidad de recursos. Lo ideal siempre es descartar trombos con un ETE.

¿Con qué fármacos cardiovertir?

- Amiodarona:** Es el fármaco de elección en la mayoría de los casos.
- Corazón sano (sin cardiopatía estructural):** Se pueden usar **antiarrítmicos de clase Ic**, como la **propafenona** o la **flecainida**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los antiarrítmicos de clase Ic (propafenona, flecainida) están **absolutamente contraindicados** en pacientes con **cardiopatía estructural** (corazón enfermo) debido al riesgo de proarritmia. En estos casos, solo se debe usar amiodarona.

Cardioversión Eléctrica

Cuando los fármacos fallan, la **cardioversión eléctrica** es una opción, incluso en pacientes hemodinámicamente estables, para restaurar el ritmo sinusal.

Manejo al Alta

Al dar el alta, la decisión sobre el tratamiento a largo plazo (control de ritmo vs. control de frecuencia y anticoagulación) se toma de la misma manera que en la **Fibrilación auricular crónica**:

- Se evalúa la necesidad de **anticoagulación permanente** con el score **CHA2DS2-VASc**.
- Se decide si el paciente continuará con **control de ritmo** (para mantener el ritmo sinusal) o **control de frecuencia** (para mantener una frecuencia cardíaca adecuada a pesar de la FA).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Aunque en la FA aguda siempre se anticoagula y se controla la frecuencia y se intenta cardiovertir, el manejo a largo plazo (anticoagulación y estrategia de control de ritmo/frecuencia) se decide según los mismos criterios que para la FA crónica. La mayoría de los pacientes con FA crónica suelen quedar con control de ritmo y anticoagulados, especialmente si tienen un **CHA2DS2-VASc > 0**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 55 años previamente sano consulta por palpitaciones de inicio hace 8 horas. ECG confirma FA. Hemodinámicamente estable, sin cardiopatía estructural conocida."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

FA de < 48 horas en paciente estable sin cardiopatía: se puede intentar cardioversión farmacológica (Flecainida 'pill-in-the-pocket' o Amiodarona) o eléctrica SIN necesidad de anticoagulación previa ni ETE. Si > 48 horas o duración incierta: anticoagular 3 semanas antes de cardiovertir o realizar ETE para descartar trombo auricular.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- FA de reciente comienzo es aquella con menos de 48 horas de evolución
- En inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica inmediata sin importar el tiempo de evolución
- Con FA menor a 48 horas se puede cardiovertir sin anticoagulación previa prolongada
- Tras cardioversión se mantiene anticoagulación mínimo 4 semanas por aturdimiento auricular
- Siempre buscar causas precipitantes reversibles como sepsis, hipertiroidismo o alcohol
- La flecainida oral es eficaz para cardioversión farmacológica en corazón estructuralmente sano
- Holiday heart es FA desencadenada por consumo excesivo de alcohol

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIBRILACIÓN AURICULAR DE RECIENTE COMIENZO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 55 años llega a urgencias con palpitaciones de 6 horas de evolución. ECG muestra FA con respuesta ventricular rápida de 150 lpm. PA 120/80, sin signos de congestión. Sin cardiopatía conocida. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Anticoagular 3 semanas y luego cardiovertir
- B)** Cardioversión farmacológica con flecainida y anticoagulación concomitante
- C)** Solo control de frecuencia con metoprolol
- D)** Cardioversión eléctrica urgente
- E)** ETE previo a cualquier intento de cardioversión

PREGUNTA 2

Paciente con FA de inicio súbito hace 3 horas, PA 70/40, confuso, extremidades frías. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A)** Amiodarona endovenosa
- B)** Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata
- C)** Anticoagular y esperar
- D)** Metoprolol endovenoso para control de frecuencia
- E)** Realizar ETE antes de cardiovertir

PREGUNTA 3

Paciente cardiovertido exitosamente de FA a ritmo sinusal. La FA duró 36 horas. CHA₂DS₂-VAsC de 0. ¿Por cuánto tiempo debe mantener anticoagulación?

- A)** No requiere anticoagulación post cardioversión
- B)** 1 semana
- C)** 4 semanas mínimo
- D)** 6 meses
- E)** De por vida

RESUMEN: FIBRILACIÓN AURICULAR DE RECIENTE COMIENZO

La fibrilación auricular de reciente comienzo se refiere a aquella con menos de 48 horas de evolución, lo que tiene implicancias terapéuticas importantes, especialmente respecto a la posibilidad de cardioversión sin anticoagulación prolongada previa. La evaluación inicial incluye estabilidad hemodinámica, búsqueda de causas reversibles y decisión entre control de frecuencia o control de ritmo. En pacientes hemodinámicamente inestables, la cardioversión eléctrica sincronizada es urgente independiente del tiempo de evolución. En pacientes estables con FA menor a 48 horas, se puede cardiovertir de forma segura con anticoagulación concomitante, sin necesidad de anticoagulación previa de 3 semanas ni ecocardiograma transesofágico. La cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica con flecainida, propafenona o amiodarona según la cardiopatía de base. Después de la cardioversión, se debe mantener anticoagulación por al menos 4 semanas independiente del CHA2DS2-VASc, ya que la aurícula puede tener aturdimiento mecánico post cardioversión con riesgo de formación de trombos. La decisión de anticoagulación a largo plazo depende del CHA2DS2-VASc habitual. Siempre buscar y tratar causas precipitantes como infecciones, cirugía reciente, hipertiroidismo o consumo excesivo de alcohol.